PEDIATRIC NURSING · MERGED LECTURE & BOOK SUMMARY

Hospitalization of *Children*

The stressors of hospitalization, separation anxiety phases, age-specific reactions, the effects on child and family, and the nursing interventions from admission to discharge.

Merged Summary · **Lecture Slides + Textbook Chapter** · *Pediatric Nursing Department · 2025–2026*

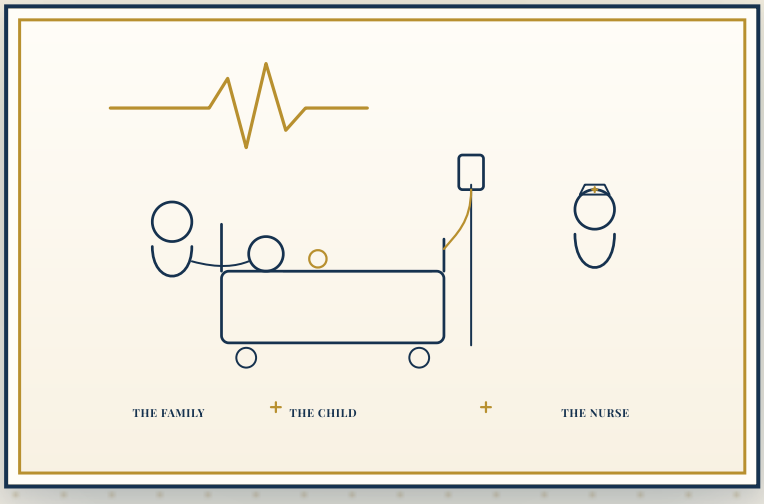


PLATE — *Hospitalization breaks family unity — the nurse stands between the vulnerable child and an unfamiliar world, keeping the family close and the fear manageable.*

Duas Before Studying

ابدأ مذاكرتك بهذه الأدعية المباركة لتيسير الفهم والحفظ والعلم النافع:

دعاء قبل المذاكرة

اللَّهُمَّ افْتَحْ عَلَيَّ فُتُوحَ الْعَارِفِينَ بِحِكْمَتِكَ، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، وَاشْرَحْ لِي صَدْرِي بِمَعْرِفَتِكَ

O Allah, open upon me the openings of the wise with Your wisdom, ease my affair, and expand my chest with Your knowledge.

دعاء الفهم

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فَهْمَ النَّبِيِّينَ، وَحِفْظَ الْمُرْسَلِينَ، وَالْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ

O Allah, I ask You for the understanding of the Prophets, the memorization of the Messengers, and the near Angels.

دعاء سيدنا موسى عليه السلام

رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي

My Lord, expand for me my chest, ease for me my task, and untie the knot from my tongue that they may understand my speech. [Surah Taha: 25-28]

دعاء العلم النافع

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَرِزْقًا طَيِّبًا، وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا

O Allah, I ask You for beneficial knowledge, good provision, and accepted deeds. [Ibn Majah]

دعاء تيسير العلم

اللَّهُمَّ لَا سَهْلَ إِلَّا مَا جَعَلْتَهُ سَهْلًا، وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزْنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلًا

O Allah, there is no ease except in what You have made easy, and You make difficulty, if You wish, easy. [Ibn Hibban]

نية المذاكرة

نَوَيْتُ بِمُذَاكَرَتِي هَذِهِ خِدْمَةَ مَرْضَى الْمُسْلِمِينَ وَنَفْعَ أُمَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ ﷺ

I intend by this study to serve the sick of the Muslims and benefit the Ummah of your Prophet Muhammad ﷺ.

💡 **نصيحة:** ابدأ بـ **بسم الله**، وصلِّ على النبي ﷺ، واجعل نيتك **خدمة مرضى المسلمين** — فالطب والتمريض عبادة إذا صحت النية.

Introduction & The 4 Stressors of Hospitalization

Introduction to Hospitalization

When a child is born, parents and health professionals hope for a healthy child. Nevertheless, illness will always occur; these illnesses can be **acute** (like the common cold) or **persistent** (like cystic fibrosis and children with disabilities). Hospitalization of children is a break in the unity of the family. Infants and children are not the only ones who experience distress; **mothers also experience it** when they leave their children in the hospital, because mothers need a continuous relationship with their young children.

Therefore, **the nurse has the main role** in helping the children and their parents adjust to the situation. The nurses' attitude is probably the most important factor in the emotional atmosphere during admission and hospitalization.

⚠ **The Challenge:** Frequently, nurses are unfamiliar with children who are cognitively impaired, and may cope by ignoring or isolating the child. This approach **may also be destructive** to the child's sense of self-esteem and optimum development and **may impair** the parents' ability to cope with the stress. Nurses must use the **mutual participation model** in planning care.

Note: Each age group has different cognitive, emotional, and social capacities, which influence how they perceive and cope with the stress of being in the hospital.

The 4 Stressors of Hospitalization

1
Separation Anxiety 6 months – 6 years

2
Loss of Control Physical restriction, altered routine/rituals, enforced dependency

3
Fear of the Unknown

4
Bodily Injury and Pain

مقدمة: المرض قد يكون **حاداً** (كالبرد) أو **مستمراً** (كالتليف الكيسي). دخول المستشفى هو انقطاع لوحدة الأسرة. **الأمهات أيضاً** يعانين عند ترك أطفالهن لاحتياجهن لعلاقة مستمرة. **للممرضة الدور الرئيسي** في مساعدة الأسرة على التكيف. عزل الطفل (خاصة ذوي الإعاقات المعرفية) **قد يكون مدمراً** لتقديره لذاته **وقد يعيق** تكيف الوالدين؛ لذا يجب استخدام **نموذج المشاركة المتبادلة. الضغوط الأربعة:** 1. قلق الانفصال (6 شهور - 6 سنوات) · 2. فقدان السيطرة (قيود جسدية، تغير الروتين، الاعتماد القسري) · 3. الخوف من المجهول · 4. الإصابة الجسدية والألم.

Reactions & Coping: Infants & Toddlers

INFANTS (0–12 MONTHS)

— **Emotional Reactions (highest age risk):** Limited understanding; primarily affected by changes in routine, separation, and unfamiliar environments.

— **Separation Anxiety (6–18 months):** Distress when separated from primary caregivers, **especially when they are alone in an unfamiliar setting**.

— **Fear and Discomfort:** Shown through crying, irritability, and difficulty sleeping.

— **Coping Strategies:** Provide **familiar items** (favorite blanket/stuffed animal). Ensure **parental presence** (voice and scent provide security).

TODDLERS (1–3 YEARS)

— **Emotional Reactions:** Developing independence but limited language skills. May experience **confusion, fear, and frustration** due to inability to understand reasons for hospitalization.

— **Separation Anxiety:** Strongly distressed when separated from parents, **especially if they don't understand why they are in the hospital**.

— **Regression:** Bed-wetting or thumb-sucking in response to stress.

— **Fear of Strangers and Pain:** Fearful of procedures, staff, surroundings; resist treatments.

— **Coping Strategies:** Maintain **routines** & comforting presence. Use **simple, clear explanations**. Provide **distraction** (toys, books, videos).

الرضع (0-12 شهر): أعلى فئة خطورة؛ فهمهم محدود. **قلق الانفصال (6-18 شهراً):** ضيق عند الانفصال، **خاصة عندما يكونون بمفردهم في بيئة غير مألوفة. التكيف:** أشياء مألوفة وحضور الوالدين (الصوت والرائحة). **الدارجون (1-3 سنوات):** استقلال ناشئ ولغة محدودة؛ يعانون من **الارتباك والخوف والإحباط** لعدم فهمهم الأسباب. قلق انفصال **خاصة إذا لم يفهموا سبب وجودهم في المستشفى، انتكاس** (تبول لاإرادي، مص إصبع)، وخوف من الغرباء والألم. **التكيف:** الحفاظ على الروتين، شرح بسيط وواضح، والإلهاء.

Reactions & Coping: Preschoolers & School-Age

PRESCHOOLERS (3–5 YEARS)

— **Emotional Reactions:** Better language but still have **magical thinking**.

— **Magical Thinking:** Might think they caused their illness due to **something they did or didn't do** (e.g., *"I didn't eat my vegetables, so I got sick"*).

— **Fear and Anxiety:** Fear of the unknown (needles, doctors, or the **hospital environment**).

— **Separation Anxiety:** Afraid to be separated from parents.

— **Coping Strategies: Reassurance** that illness is not their fault, and **parents' presence is comforting**. **Preparation** with simple, honest explanations. **Play Therapy** (dolls, drawings).

SCHOOL-AGE (6–12 YEARS)

— **Emotional Reactions:** Cognitively developed, better understanding, but fear pain and loss of control.

— **Fear of Pain:** Pain or fear of the unknown (e.g., surgery, needles) can cause significant anxiety.

— **Fear of Separation:** Fear being away from home, school, friends; missing activities.

— **Desire for Control:** Seek independence; frustrated if helpless.

— **Coping Strategies: Honest communication** (age-appropriate, truthful). **Involvement in Decision-Making** (e.g., choosing IV arm). **Normalizing** the experience (schoolwork, friend visits).

ما قبل المدرسة (3-5): تفكير سحري، يعتقدون أنهم سببوا مرضهم بسبب **شيء فعلوه أو لم يفعلوه** (مثل: "لم آكل الخضروات فأ مرضت"). الخوف من المجهول (الإبر، الأطباء، **بيئة المستشفى**). **التكيف:** طمأنتهم أن المرض ليس خطأهم وأن **حضور الوالدين يريحهم**، التحضير المسبق، واللعب العلاجي. **سن المدرسة (6-12):** خوف من الألم أو المجهول والانفصال عن الأصدقاء والمدرسة، ورغبة في السيطرة. **التكيف:** تواصل صادق، مشاركتهم في اتخاذ القرار، وتطبيع التجربة (الواجبات، الزيارات).

Adolescents & The 3 Phases of Separation Anxiety

ADOLESCENTS (13–18 YEARS)

— **Emotional Reactions:** Advanced understanding; concerned with impact on **social identity** and independence.

— **Fear of the Future:** Long-term effects, **need for further treatment**, or how it might affect physical appearance.

— **Privacy and Independence:** Struggle with loss of autonomy; feel **embarrassed by medical staff or the presence of family members**.

— **Peer Concerns:** How hospitalization affects relationships with friends or their social standing.

— **Coping Strategies: Respect for Privacy** & confidentiality. **Involvement in Decisions**. **Peer Support** (visits, group activities).

SEPARATION ANXIETY INTRO

— The major stress from middle infancy throughout preschool years, **especially for children ages 6 to 30 months**, is separation anxiety.

— In addition, considerable evidence suggests that even with stressors such as separation, **children are remarkably adaptable, and permanent ill effects are rare**.

Phases and Manifestations of Separation Anxiety

PHASE	MANIFESTATIONS
1 · Protest	**Infants:** Cries, screams, searches for parents with eyes, clings. Avoids and rejects contact with strangers. **Toddlers:** Verbally attacks strangers ("go away"). Physically attacks (kicks, bites, hits, pinches). Attempts to escape or physically force parents to stay. **Refuse the attention of anyone else, and are inconsolable in their grief.** Crying is continuous, ceasing only with physical exhaustion. **Behavior possibly lasts from hours to days.**
2 · Despair	Crying stops, depression is evident. Inactive, withdrawn, sad, uncommunicative. Uninterested in environment, play, or food. **Regresses** to earlier behavior (thumb sucking, bed wetting, use of pacifier, **use of bottle**). Physical condition deteriorates due to refusal to eat, drink, or move.
3 · Detachment (Denial)	Increased interest in surroundings. Interacts with **strangers or familiar caregivers**. Forms new but superficial relationships. Appears happy. Detaches to escape emotional pain; becomes self-centered, attaching primary importance to material objects. Occurs usually after prolonged separation; **rarely seen in hospitalized children**. Represents a superficial adjustment to loss.

المراهقون (13-18): قلق على **الهوية الاجتماعية** والاستقلال، الخوف من المستقبل **والحاجة لمزيد من العلاج**، والشعور **بالإحراج من الطاقم الطبي أو وجود أفراد الأسرة.** **التكيف:** احترام الخصوصية، المشاركة في القرار، ودعم الأقران. **قلق الانفصال:** الضغط الرئيسي خاصة للأطفال **من 6 إلى 30 شهراً.** الأطفال **قابلون للتكيف بشكل ملحوظ، والآثار السلبية الدائمة نادرة. المراحل:** 1. **الاحتجاج:** بكاء، صراخ، رفض اهتمام الآخرين، **لا يمكن تعزيتهم في حزنهم**، هجوم جسدي/لفظي على الغرباء، **يستمر من ساعات إلى أيام.** 2. **اليأس:** اكتئاب، انسحاب، انتكاس (مص إصبع، **استخدام الزجاجة**)، تدهور جسدي. 3. **الانفصال:** تكيف سطحي، يتفاعل مع الغرباء **أو مقدمي الرعاية المألوفين،** علاقات سطحية، التعلق بالأشياء المادية، **نادراً ما يرى في الأطفال بالمستشفيات.**

Factors Affecting Hospitalization & Nurse's Role

FACTORS AFFECTING CHILD'S HOSPITALIZATION & SEPARATION ANXIETY

- Age of the child & Previous experiences.
- Extent of previous social contacts outside the family.

PREPARATION FOR HOSPITALIZATION DEPENDS ON

- Nature of Illness.
- Child's developmental and understanding level.
- History of coping with hospitalization.
- Quality and duration of the illness or hospitalization experience (temporary or permanent).
- Family's attitudes toward separation and hospitalization.

Nurse's Role in Separation Anxiety

The stressors may cause short- and long-term negative outcomes (related to length/number of admissions, **multiple invasive procedures**, and the parents' anxiety). Common responses include **regression, separation anxiety, apathy, fears, and sleeping disturbances**, especially for children **younger than 7 years of age**.

- **Family-centered care** concepts: information sharing, negotiation, collaboration, **providing the family context**, encouraging parents to ask questions, letting them participate on rounds.
- Provide care with **limited number of personnel**.
- Allow the child to express their feelings.
- Allow the child to be independent and provide positive reinforcement.
- Orient the child to unfamiliar settings (e.g., OR).
- Develop sense of familiarity using **transitional objects** (toys, picture, clothes).

العوامل المؤثرة على دخول المستشفى وقلق الانفصال: عمر الطفل والخبرات السابقة · مدى التواصل الاجتماعي السابق خارج الأسرة. **التحضير لدخول المستشفى يعتمد على:** طبيعة المرض · المستوى النمائي والفهمي · تاريخ التكيف السابق · جودة ومدة المرض (مؤقت أو دائم) · اتجاهات الأسرة. **دور الممرضة:** النتائج السلبية الشائعة (خاصة تحت 7 **سنوات**) تشمل: الانتكاس، قلق الانفصال، البلادة، **المخاوف**، واضطرابات النوم. **التدخلات:** الرعاية المتمركزة حول الأسرة (تشمل **توفير سياق الأسرة**) · تقديم الرعاية بعدد **محدود من الأفراد** · السماح بالتعبير والاستقلال · التوجيه للأماكن غير المألوفة · استخدام **الأشياء الانتقالية.**

Effects of Hospitalization on the Child

PHYSICAL EFFECTS

- Anemia and nutritional problems
- Anorexia
- Infections
- Constipation
- General weakness

PSYCHOSOCIAL EFFECTS (POST-HOSPITAL BEHAVIORS)

- Initial aloofness toward parents (minutes to days)
- Tendency to cling to parents
- Demanding parents' attention
- Vigorously opposing any separation
- New fears (e.g., nightmares)
- Resistance to going to bed, night waking
- Withdrawal and shyness
- Hyperactivity
- Temper tantrums
- Attachment to blanket or toy
- Regression in newly learned skills (e.g., toileting)
- Emotional coldness, followed by intense demanding dependence
- Anger toward parents
- Jealousy toward others (e.g., siblings)

الآثار الجسدية: فقر الدم ومشاكل التغذية · فقدان الشهية · العدوى · الإمساك · الضعف العام. **الآثار النفسية-الاجتماعية (سلوكيات ما بعد المستشفى):** فتور أولي تجاه الوالدين · التشبث · طلب الانتباه · معارضة الانفصال بشدة · مخاوف جديدة (كوابيس) · مقاومة النوم والاستيقاظ ليلاً · انسحاب وخجل · فرط نشاط · نوبات غضب · التعلق ببطانية أو لعبة · انتكاس المهارات المكتسبة (التواليت) · برود عاطفي يتبعه اعتماد شديد مطالب · غضب من الوالدين · غيرة من الآخرين (كالأشقاء).

Parents' Emotional Reactions to Child's Hospitalization

The crisis of childhood illness and hospitalization affects every member of the family. Parents' reactions depend on a variety of factors. Although one cannot predict which factors are most likely to influence their response, several variables have been identified.

Common Themes Identified in Parents' Reactions

- Feeling an overall sense of **helplessness**.
- **Questioning the staff's skills**.
- Accepting the reality of hospitalization.
- Needing to have information explained in **simple language**.
- Dealing with **fear** & coping with **uncertainty**.
- Seeking **reassurance** from the health care team.

Parent's Anxiety and Feeling of Guilt Due To (7 Fears)

1. **Fear of unknown**
2. **Fear of separation** from their children
3. **Fear of suffering** that the children will suffer
4. **Fear of unloving nurse**
5. **Economic cost** of hospitalization
6. **Hospital infection** child may catch
7. **Society's judgment** illness as reflection of parents

Reassurance from the Health Care Team

Can be in the form of: **Collaboration** · **Information sharing** · **Preparation for procedures** · Ensuring formal and informal support for the family · Providing information in an **unbiased and culturally sensitive** manner.

أزمة المرض تؤثر على كل فرد في الأسرة. ردود فعل الوالدين تعتمد على عوامل متنوعة لا يمكن التنبؤ بها. **الموضوعات الشائعة:** العجز، التشكيك في مهارات الطاقم، تقبل الواقع، الحاجة لشرح بسيط، الخوف وعدم اليقين، وطلب الطمأنينة. **مصادر القلق والذنب (7 مخاوف):** الخوف من المجهول، الانفصال، معاناة الطفل، ممرضة غير حنونة، التكلفة المادية، عدوى المستشفى، ونظرة المجتمع. **الطمأنينة تقدم عبر:** التعاون، مشاركة المعلومات، التحضير للإجراءات، الدعم، وتقديم المعلومات بأسلوب غير متحيز وحساس ثقافياً.

Nursing Interventions: Admission to Discharge

General Nursing Interventions to Reduce Effects

- Apply pre-hospitalization preparation program.
- Encourage **rooming in** trend.
- Involvement of parents in care.
- Continuity of parent-child relationship.
- Use of non-pharmacological pain relieve measures.
- **Properly assess the child past experience** to hospitalization.
- Apply **hospital tour**.
- Assign one nurse or two for one child.
- Allow parents to bring child's personal objects.
- Allow visits by peers, siblings, and **relatives**.
- Maintain the child's routines.
- Maintain safe hospital environment.
- Allow the child to share in simple hospital activities.

Psychological Preparation on Admission

- Allow the mother of the child to stay with the child.
- The nurse introduces herself to the child and their parents.
- Introduce the child to other children.
- Explain the admission procedures **to the child and their parents**.

Information the Nurse Must Have About the Child

1 **Name and nickname**	2 **Sleeping habits**
3 **Eating habits**	4 **Toilet habits**
5 **Play habits**	6 **School activities**

Preparation of Children and Parents for Discharge

- Educate mothers how to care for their children at home **during hospitalization**.
- Explain to the mother the child's behavior could regress after hospitalization such as (bed wetting, soiling, nail-biting), especially if they were admitted without them.
- Describe the necessary care for the children and follow up.

التدخلات العامة: برامج التحضير، بقاء الأم (rooming-in)، إشراك الوالدين، استمرارية العلاقة، مسكّنات غير دوائية، **التقييم السليم لخبرة الطفل السابقة، جولة المستشفى**، تعيين ممرض/ة ثابت، السماح بالأغراض الشخصية وزيارات الأقران والأشقاء **والأقارب**، الحفاظ على الروتين والبيئة الآمنة. **عند القبول:** بقاء الأم، تعريف الممرضة بنفسها، تعريف الطفل بغيره، شرح الإجراءات **للطفل ووالديه. المعلومات المطلوبة:** الاسم/اللقب، عادات النوم، الأكل، التواليت، اللعب، والأنشطة المدرسية. **التحضير للخروج:** تعليم الأم الرعاية المنزلية **أثناء الإقامة**، تحذيرها من الانتكاس السلوكي (تبول لاإرادي، قضم أظافر) خاصة إذا دخل بدون والديه، وشرح الرعاية اللازمة والمتابعة.

Functions of Play in the Hospital (12 Functions)

1 **Mastery** Facilitates mastery over an unfamiliar situation	2 **Control** Provides opportunity for decision making and control
3 **Lessen Stress** Helps to lessen stress of separation	4 **Assessment** Helps in assessment and diagnosis
5 **Developmental Needs** Meets ongoing developmental needs	6 **Continuation** Provides for continuation of development
7 **Recovery** Speeds recovery and rehabilitation	8 **Security** Helps the child feel more secure in a strange environment
9 **Expression** Provides a means to release tension and express feelings	10 **Understanding** Helps children have an age-appropriate understanding of illness and treatment

11	12
Creativity Provide an expressive outlet for creative ideas and interests	**Therapeutic Goals** Provide a means for accomplishing therapeutic goals

وظائف اللعب في المستشفى (12 وظيفة): 1. تسهيل السيطرة على المواقف غير المألوفة · 2. توفير فرصة لاتخاذ القرارات والسيطرة · 3. المساعدة في تقليل ضغط الانفصال · 4. المساعدة في التقييم والتشخيص · 5. تلبية الاحتياجات النمائية المستمرة · 6. توفير استمرارية النمو · 7. تسريع التعافي والتأهيل · 8. مساعدة الطفل على الشعور بأمان في بيئة غريبة · 9. توفير وسيلة لتفريغ التوتر والتعبير عن المشاعر · 10. مساعدة الأطفال على فهم المرض والعلاج بطريقة تناسب أعمارهم · 11. توفير منفذ تعبيري للأفكار والاهتمامات الإبداعية · 12. توفير وسيلة لتحقيق الأهداف العلاجية.

Quick Revision & Final Recap

Critical Numbers to Memorize

ITEM	VALUE
Major stressors of hospitalization	**4** (Separation, Loss of control, Fear of unknown, Bodily injury/pain)
Separation anxiety window	**6 months – 6 years** (especially **6 to 30 months**)
Phases of separation anxiety	**3** (Protest → Despair → Detachment)
Age groups with reactions & coping	**5** (Infant, Toddler, Preschool, School-age, Adolescent)
Parental fears / guilt sources	**7**
Habits to gather on admission	**6** (name, sleeping, eating, toilet, play, school)
Functions of play in hospital	**12**
Most vulnerable age for negative outcomes	Younger than **7 years**

Common Confusions — Clear Answers

YOU MIGHT THINK...	BUT ACTUALLY...
A child who stops crying is improving	Stopped crying + withdrawal + refusal to eat = **Despair phase** (deterioration, not improvement).
Detachment means the child is happy	It is a **superficial adjustment** to escape emotional pain; rarely seen in hospitalized children.
Preschoolers understand why they are ill	They have **magical thinking** → believe illness is caused by something they did or didn't do.
Short parental visits are enough	Mothers need a continuous relationship with their young children; parental presence soothes infants and reduces distress.

💎 **In one sentence:** Hospitalization imposes 4 stressors on the child; the nurse manages separation anxiety (especially ages 6-30 months) through its 3 phases using family-centered care, limited personnel, transitional objects, and 12 functions of play, while supporting parents through their 7 fears and educating them for discharge.

💎 **في جملة واحدة:** يفرض دخول المستشفى 4 ضغوط على الطفل؛ وتدير الممرضة قلق الانفصال (خاصة من 6 إلى 30 شهراً) عبر مراحله الثلاث باستخدام الرعاية المتمركزة حول الأسرة، عدد محدود من الأفراد، الأشياء الانتقالية، و12 وظيفة للعب، مع دعم الوالدين خلال مخاوفهم السبعة وتثقيفهم للخروج.

Self-Evaluation Questions (From the Book)

1 **A hospitalized infant, for two days, cries while admitted with his mother when nurse provide care for him. The nurse realizes this behavior is typical of:**

- ◯ a) Despair.
- ◯ b) Protest.
- ◯ c) Repression.
- ◯ **d) Stranger anxiety.** ✓

الإجابة: **d** — البكاء عند تقديم الممرضة (شخص غريب) للرعاية بينما الطفل مع أمه هو خوف من الغرباء (**Stranger anxiety**)، وليس احتجاج على الانفصال لأن الأم موجودة.

2 **Which of the following can help reduce a child's anxiety during hospitalization?**

- ◯ a) Keeping the child in an unfamiliar room
- ◯ **b) Allowing the child to bring a favorite toy or comfort item** ✓
- ◯ c) limiting parental visits to once a day
- ◯ d) Avoiding any communication with the child about their condition

الإجابة: **b** — السماح بإحضار لعبة مفضلة (شيء انتقالي) يبني الألفة ويقلل القلق.

3 **What is a primary concern for nurses when caring for a hospitalized child?**

- ◯ a) Ensuring the child's room is quiet at all times
- ◯ **b) Monitoring the child's nutritional intake and hydration ✓**
- ◯ c) Giving the child daily visitors to prevent boredom
- ◯ d) Restricting physical activity to minimize injury

الإجابة: b — من الآثار الجسدية فقدان الشهية ومشاكل التغذية، فمراقبة التغذية والترطيب أولوية.

4 **How can parents help their child adjust to being hospitalized?**

- ◯ a) Discouraging any expression of fear or sadness
- ◯ **b) Providing consistent routines, such as bedtime rituals ✓**
- ◯ c) Limiting the child's contact with medical staff
- ◯ d) Telling the child that the hospital is a punishment for misbehavior

الإجابة: b — الحفاظ على الروتين المتسق يعوض فقدان السيطرة ويساعد الطفل على التكيف.

5 **Which of the following is an important factor in preventing infections during a child's hospital stay?**

- ◯ a) Encouraging the child to touch surfaces freely
- ◯ **b) Regular hand hygiene for both staff and visitors ✓**
- ◯ c) Keeping the child's bed uncovered at all times
- ◯ d) Providing sugary foods to boost energy levels

الإجابة: b — العدوى من الآثار الجسدية، ونظافة اليدين المنتظمة للطاقم والزوار خط الدفاع الأول.